



ANNALES OFFICIELLES

EVCF 2009

Connaissances fondamentales

Médecine générale

Cette annale contient

4 sujets · 22 questions

01 SUJET 1**VIGNETTE CLINIQUE**

Un homme de 55 ans consulte pour une hypertension mal contrôlée sous bithérapie par 1 ESIDREX (Hydrochlorothiazide) 25mg/j + AMLOR (Amlodipine) 5mg/j. Sa pression artérielle au cabinet médical est à 155 / 92 mmHg. Il a un poids de 88 kg pour 1.70 m avec un tour de taille à 106 cm. Il boit régulièrement (chaque jour) 8 verres standards de boissons alcoolisées et fume 30 cigarettes par jour depuis 20 ans. Son bilan sanguin à jeun montre une kaliémie à 3.2 mmol/l et un profil lipidique avec 2.60g/l de cholestérol 0.35 g/l de cholestérol HDL et 2.20 g/l de triglycérides sans traitement hypolipémiant.

1**QUESTION 1**

Calculer l'index de masse corporel (IMC).

2**QUESTION 2**

Définir le type de morphologie : poids normal surpoids obésité androïde obésité morbide maigreur

3**QUESTION 3**

Calculer sa consommation d'alcool en g/j.

4**QUESTION 4**

Calculer sa consommation totale de tabac en paquets / années.

5**QUESTION 5**

Quel est le mécanisme le plus probable de son hypokaliémie ? alcool diurétique hypéraldostérisme primaire laxatifs consommation de réglisse

6**QUESTION 6**

Quelles sont les 3 causes les plus probables de résistance au traitement anti-hypertenseur ? dyslipidémie alcool mauvaise observance thérapeutique hypertension secondaire surcharge pondérale

02 SUJET 2

VIGNETTE CLINIQUE

Un homme de 35 ans sans antécédent connu, arrive aux urgences pour dyspnée aiguë, fièvre à 40 °C avec douleur basithoracique droite. Les symptômes ont débutés brutalement la veille au soir. Vous suspectez une pneumonie franche lobaire aiguë droite.

1**QUESTION 1**

Quels critères de gravité recherchez-vous parmi les propositions suivantes ?
expectoration purulente état de choc fréquence respiratoire >30/mn frissons
somnolence et/ou confusion

2**QUESTION 2**

Quel germe paraît le plus probable ? Escherichia coli H1N1 Haemophilus influenza
Mycoplasma pneumoniae Streptococcus pneumoniae

3**QUESTION 3**

Quelles sont les caractéristiques microbiologiques de ce germe ? cocci
GRAM-positif cocci GRAM-négatif diplocoque bacille GRAM-négatif virus

4**QUESTION 4**

Les gaz du sang effectués en air ambiant montrent les résultats suivants : PH
7.40 - PO₂ = 55mmHg - P CO₂=30mmHg HCO₃ = 24mM - Sa O₂ =89%
Comment calculez-vous l'eff et shunt ? Ce patient a-t-il un eff et shunt ? justifiez
par un calcul.

5**QUESTION 5**

Quel est le mécanisme d'action de la pénicilline ? se fixe sur la sous-unité 30s du
ribosome inhibe la synthèse du peptidoglycane se fixe sur l'ADN-gyrase inhibe la
thymidine kinase inhibe la protéase

03**SUJET 3**

VIGNETTE CLINIQUE

Une femme de 76 ans consulte son médecin pour le suivi d'un diabète de type 2 équilibré par régime. Elle ne fume pas, elle ne boit pas. Elle n'a pas de symptôme actuel. Son examen clinique est normal hormis une pression artérielle à 170/80 mmHg, un IMC à 32 kg/m² et un pouls irrégulier. Son bilan sanguin est normal (HbA1c à 6%) sauf la TSH à 0.1 UI/L avec FT4 à 16 pg/ml. L'électrocardiogramme montre une arythmie complète par fibrillation auriculaire avec rythme cardiaque moyen à 82 bpm.

1**QUESTION 1**

Quels sont les facteurs favorisants possibles de son arythmie ? hyperthyroïdie hypertension artérielle abus d'alcool infection aiguë hypothyroïdie

2**QUESTION 2**

Quelle(s) complication(s) cardiovasculaire(s) cette arythmie fait-elle craindre ? infarctus du myocarde phlébite dysfonction cardiaque accident vasculaire cérébral ischémique accident vasculaire cérébral hémorragique

3**QUESTION 3**

Quels éléments permettent d'apprécier le risque cérébro-vasculaire de cet arythmie cardiaque (score de Chads) ? antécédent personnel d'accident vasculaire cérébral hypertension artérielle diabète insuffisance cardiaque congestive âge > 75 ans sexe féminin IMC > 30 kg/m²

4**QUESTION 4**

Que prescrivez-vous comme traitement antithrombotique au long cours ? Aspirine Anti-vitamine K Plavix Cordarone Statine

5**QUESTION 5**

Quel est l'élément de surveillance du traitement anti-thrombotique choisi ?

6**QUESTION 6**

Chez cette patiente la Cordarone est contre-indiquée. Quels sont les mécanismes d'interaction entre la Cordarone et les hormones thyroïdiennes : Bloque la transformation périphérique de T3 en T4 Bloque la transformation périphérique de T4 en T3 surcharge iodée dans l'organisme diminue le taux de cholestérol sanguin se fixe à la thyroglobuline

04**SUJET 4**

VIGNETTE CLINIQUE

Un homme de 60 ans consulte pour la prise en charge d'un myélome multiple.

1**QUESTION 1**

Parmi les immunoglobulines suivantes quelle est la seule qui n'est jamais rencontrée dans le myélome multiple ? IgA IgG IgE IgM Chaîne légère Kappa

2**QUESTION 2**

Sa calcémie est à 2,51/mM, ses protides totaux à 86g/L, son albumine à 28g/L. Calculez la calcémie corrigée en mM.

3**QUESTION 3**

Quelle prolifération cellulaire est responsable du myélome ? Lymphocyte B Lymphocyte T Plaquettes Plasmocyte Macrophage

4**QUESTION 4**

Mécanisme d'action des Biphosphonates ? Chelateur de calcium Apoptose de fibroblaste Action antiostéoclastique Inhibition de la réabsorption tubulaire du phosphore Inhibition de la calcium Binding Protein

5**QUESTION 5**

Parmi les examens suivants, quel est celui qui est contre indiqué au cours du myélome ? Echographie rénale Ostéodensitométrie Scintigraphie osseuse Radiographie standard Tomodensitométrie avec injection de produit de contraste iodé. FILENAME \p G:\Pae\2009\Spec.71\EVCf.71.DOC Page NUMPAGES ~sh^hVhNVhDsN h?PX hwFì h=/E h6uñ h"gi gdòG gdÀb gd6uñ äya\$ xpxpx h=&p gd=&p gdm: gdwFì h`;k hP-e héCÜ gdP-e gdéCÜ gdó' higö :pa\$ gd`;k gdi) gd_7x bgd_7x gdigö hR_g h_7x gdÒ# :p?PX Z3R qbÔÿ >ä&F .RNØ| jsÒVÂÀnÖÿ aqÓXE?Sjz Jdßp:y Jdßp ðmLZ jsÒVE?Sj Rh4Ñ 6=èP : "ä DfÔ[Læhs òùOh ODONTOLOGIE Prodiser Titre Document Microsoft Word MSWordDoc Word.Document.8